

Síndrome dos ovários policísticos · Rotterdam

SOP exige "e2 critérios de Rotterdam: hiperandrogenismo, ovulação disfuncional, morfologia multicística — com exclusão de mimetizadores (tireoide, hiperprolactinemia, HAC).

Metabolismo

Lembre - Metabolismo

Rastreie DM/intolerância, dislipidemia e HAS. Mudança de estilo de vida é base — mesmo sem desejo gestacional imediato.

Fórmula de prova: hiperandrogenismo + anovulação + USG multicístico (2/3), após excluir outras causas.

Rotterdam (conceito)

2 de 3 criterios + exclusoes

HA clinico/lab + anovulacao + USG (2/3)

Excluir: TSH, prolactina, 17-OHP; gestacao se amenorreia

Tratamento por meta

- Ciclos/hiperandrogenismo sem gestar: ACO combinado (se sem CI)
- Hirsutismo: ACO ± antiandrógeno (espironolactona) com contracepção
- Resistência insulínica/DM: metformina como adjuvante
- Infertilidade anovulatória: letrozol (1ª em muitas diretrizes) / citrato de clomifeno

Diferenciais

Condição | Pista

Hiperprolactinemia | Galactorreia; PRL !'

Hipotireoidismo | TSH !'

HAC forma não clássica | 17-OHP !'; acne/hirsutismo precoce

Tumores androgênicos | Virilização rápida; testosterona muito alta

Armadilha de prova

Atencao - Armadilha de prova

USG 'multifolicular' sozinho não fecha SOP em adolescente. Amenorreia prolongada: proteger endométrio (progestagênio/ACO) — risco de hiperplasia.

Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

SOP: critérios de Rotterdam — 2 de 3 (oligo/anovulação, hiperandrogenismo, morfologia ovariana policística), excluindo diferenciais.

Rotterdam - checklist

2 de 3 + exclusão de diferenciais

- 1) Oligo e/ou anovulação
- 2) Hiperandrogenismo clínico e/ou lab
- 3) Ovarios policísticos no US
- 4) Excluir: tireoide, hiperprolactina, HCCC
- 5) Adolescente: cuidado com US isolado

Diagnóstico: 2/3 critérios presentes

Critérios em uma linha

Critério | Como cai na prova

Oligo/anovulação | Ciclos longos, amenorreia, infertilidade

Hiperandrogenismo | Hirsutismo, acne; ! testosterona/androgênios

US policístico | "e 20 folículos/ovário ou volume !" (critérios atualizados; banca pode citar "e 12 clássico)

Exclusões | Hiperplasia adrenal, Cushing, tumores, hiperprolactinemia, tireoidopatia

Fenótipos

Dica - Fenótipos

Rotterdam gera fenótipos (com/sem hiperandrogenismo ou US). Em prova, foque no '2 de 3' e na exclusão de diferenciais.

Conduta-ideia

- Metas: ciclo, androgênios, fertilidade, risco metabólico
- ACO se sem desejo gestacional; metformina se resistência/DM
- Indução de ovulação (clomifeno/letrozol) se gravidez desejada

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1